Contrarreferencia y cierre

Finalidad y momento de uso

Registrar contrarreferencia y cierre en el momento de la actividad correspondiente a ODO-INT02. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Usuario / fecha / prestador receptor

Identificar de manera inequívoca el objeto o usuario del registro. En controles administrativos usar código y ubicación reservada del soporte; verificar identidad antes de decisiones clínicas o entrega.

Valoración / diagnóstico / intervención

Diligenciar dato concreto y pertinente a contrarreferencia y cierre. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Indicaciones / medicación / restricciones

Diligenciar dato concreto y pertinente a contrarreferencia y cierre. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Resultados pendientes / responsable / plazo

Identificar persona y rol que ejecuta o verifica, no solamente cargo genérico. Asociar autenticación válida cuando la naturaleza del registro la exige y proteger permisos de acceso.

Plan en consultorio / citas

Diligenciar dato concreto y pertinente a contrarreferencia y cierre. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Comunicación y aceptación vinculada

Registrar información particular, comprensión, voluntariedad y decisión, con apoyos o representación cuando corresponde. Vincular evidencia jurídicamente válida; no equivale a aceptación un nombre digitado aislado.

Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-INT02 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Campo	Registro
Usuario / fecha / prestador receptor	
Valoración / diagnóstico / intervención	
Indicaciones / medicación / restricciones	
Resultados pendientes / responsable / plazo	
Plan en consultorio / citas	
Comunicación y aceptación vinculada	
Cierre o escalamiento / evidencia	

Observaciones y soporte vinculado

Criterios de revisión y custodia del registro

Aplicabilidad y responsables

Relacionar este documento con sede, servicio, modalidad y tareas realmente realizadas. Designar ejecutor, suplente y revisor por nombre/rol; comprobar competencia y recursos. Si No aplica, justificar con oferta real y criterio normativo, sin utilizarlo para ocultar una actividad que sí se ejecuta.

Preparación del proceso

Reunir información y soportes descritos en sus secciones: documentos vigentes, equipos o productos identificados, condiciones de sede y proveedores verificados. Revisar fechas, integridad y coherencia entre el soporte y la operación; una certificación de otro equipo o profesional no es intercambiable.

Ejecución y evidencia

Registrar actividades reales con fecha, responsable, resultado y ubicación del soporte. Diferenciar programación de ejecución y solicitud de respuesta recibida. Mantener versión de origen, trazabilidad de cambios y acceso apropiado; no completar registros retrospectivamente sin señalar adenda.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609